

Información Paciente

Nombre : Veronica Del Carmen Huichaleo Quilam	Rut : 7.634.360-8	N° Archivo : 0905006	N° Epicrisis : 338631
Edad : 75a 4m 7d	Fecha Nacto : 16/09/1947	Sexo : Femenino	
Dirección : Baudelaire 638 V. Huidobro 638	Comuna : Puente Alto	Teléfono : 9 9302 6387	

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Pre-Hospitalización	Fecha Ingreso : 12/01/2023 17:47	Días Estadía : 11
Unidad de Egreso : Recuperación (Tránsito Pabellón)	Fecha Egreso : 23/01/2023 02:01	

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Compromiso de conciencia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

AM: Reemplazo válvula mitral mecánica (2000), FA Crónica, ACV hemorrágico secuelado con hemiparesia izquierda (Sept 2022), dependiente severa.

Fcos: Bisoprolol, atorvastatina, omeprazol, acenocumarol (TACO)

Hosp recientes: Desde 02/09/22 a 03/11/22 por ACV hemorrágico, HSD bilateral drenado quirúrgicamente, complicado con HIC de resolución qx, shock séptico de foco pulmonar y urinario, secuelado con hemiparesia izquierda

Alergias: -

Social: vive con la hija, usuaria de silla, camina con asistencia de dos personas con dificultad. No maneja dinero.

Paciente traída por hija, con antecedente de caída a nivel 24 horas previo a su ingreso, con golpe facial izquierdo, sin pérdida de conciencia ni alteración del estado neurológico inmediato. Posteriormente, 12 horas previas a la consulta, inicia cuadro de cefalea ictal que alcanza máxima intensidad a pocos minutos, localizada en zona frontal, asociada a 10 episodios de vómitos explosivos y pérdida de equilibrio. Niega otros síntomas.

AngioTAC cuello y Cerebro: ¿Sin imagen de patología vascular evidente en este estudio, se mantiene la HSA peritroncal anterior, con escasa presencia de sangre a nivel del 4to ventrículo. Sin evidencia de sangre a nivel del 3er ventrículo o los Ventrículos laterales, no se evidencia dilatación ventricular.¿

En ficha se describe en GCS 3 durante evaluación AM. Ingresa a pabellón en GCS=7: apertura ocular al dolor, retira escasamente al dolor, no emite lenguaje; pupilas isocóricas.

Instalación de DVE izquierdo, dando salida a LCR a muy aumentada presión, con tinte hemático. Se deja a 7 cm. Se envía cultivo, gram y citológico. Sin incidentes.

Paciente post instalación de DVE con mala evolución clínica e imagenológica. Sin respuesta a los diversos tipos de estímulos. En conjunto con neurología y neurocirugía se determina paciente con muy mal pronóstico neurológico. Sin respuesta ni conexión con el medio a pesar de suspender la sedación. Familiares enterados de la gravedad, acompañándola. En este contexto se mantiene apoyo de confort a lo que paciente fallece el 23/01/2023 a las 01:37 am. Se notifica a familiares.

Diagnóstico de Egreso

Fecha Epicrisis : 23/01/2023 02:10

Fecha Última Actualización: 23-01-2023 2:10:47

Página 2 de 2

Hemorragia subaracnoidea, no especificada -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

-

Plan Post Alta

-

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Raymundo Rojas Araya
Médico Tratante (Staff)